PANCRÉAS · PA-01

Kystes du pancréas · TIPMP (Kyoto 2024)

Kyoto 2024 (IAP)
stigmates de haut risque, signes inquiétants, surveillance

Définitions : **TIPMP des canaux secondaires** : kyste > 5 mm communiquant avec le canal pancréatique principal (CPP) · **TIPMP du canal principal** : dilatation segmentaire ou diffuse du CPP **> 5 mm** sans autre cause d'obstruction · **mixte** : les deux. Éliminer un pseudokyste si antécédent de pancréatite ou de traumatisme. Imagerie de référence : **IRM avec cholangio-pancréato-IRM** ; scanner et écho-endoscopie si modification.

CRITÈRES DE RISQUE · KYOTO 2024

Stigmates de haut risque → chirurgie si opérable

- Ictère obstructif avec kyste de la tête du pancréas
- **Nodule mural rehaussé ≥ 5 mm** ou composante solide
- **CPP ≥ 10 mm**
- Cytologie suspecte ou positive (dysplasie de haut grade ou adénocarcinome)

Signes inquiétants → écho-endoscopie ± ponction

- Pancréatite aiguë ; CA 19-9 > 37 U/mL ; diabète récent ou aggravé dans l'année
- **Kyste ≥ 30 mm**
- **Nodule mural rehaussé < 5 mm** ; paroi épaissie ou rehaussée
- **CPP 5–9 mm**
- Changement brutal de calibre du CPP avec atrophie d'aval
- Adénopathie
- **Croissance ≥ 2,5 mm/an**

Taille du nodule mural : hauteur en écho-endoscopie, plus grand diamètre au scanner ou en IRM. Signes inquiétants confirmés en écho-endoscopie (nodule, atteinte du CPP, cytologie) : discussion chirurgicale en RCP.

SURVEILLANCE D'UNE TIPMP NON OPÉRÉE (SANS SIGNE DE RISQUE)

TAILLE DU KYSTE	RYTHME	ARRÊT POSSIBLE
< 20 mm	Contrôle à **6 mois** une fois, puis **tous les 18 mois** si stable	Après **5 ans** sans modification ni signe inquiétant, selon l'état général et l'espérance de vie
20–29 mm	Contrôle à 6 mois **deux fois**, puis **tous les 12 mois** si stable	Non systématique
≥ 30 mm	**Tous les 6 mois**	Non

Arrêter la surveillance si le patient n'est pas opérable ou si l'espérance de vie est < 10 ans. Prudence chez le sujet jeune ou en cas de risque familial ou génétique. Kystes ≤ 5 mm : prise en charge non consensuelle, surveillance pour l'instant.

ORIENTER LE DIAGNOSTIC DE KYSTE

KYSTE	ARGUMENTS D'IMAGERIE
TIPMP	Communication avec le CPP, kystes en grappe, souvent multiples
Cystadénome séreux	Microkystique en « nid d'abeille », cicatrice centrale ± calcifiée, pas de communication
Cystadénome mucineux	Femme, corps ou queue, macrokyste avec cloisons, calcifications périphériques
Tumeur pseudopapillaire et solide	Femme jeune, masse mixte solide et kystique, composante hémorragique
Pseudokyste	Antécédent de pancréatite, paroi fine rehaussée, débris

COMPTE RENDU

Kyste
siège, taille, communication avec le CPP, nombre

CPP
calibre maximal en mm, changement de calibre

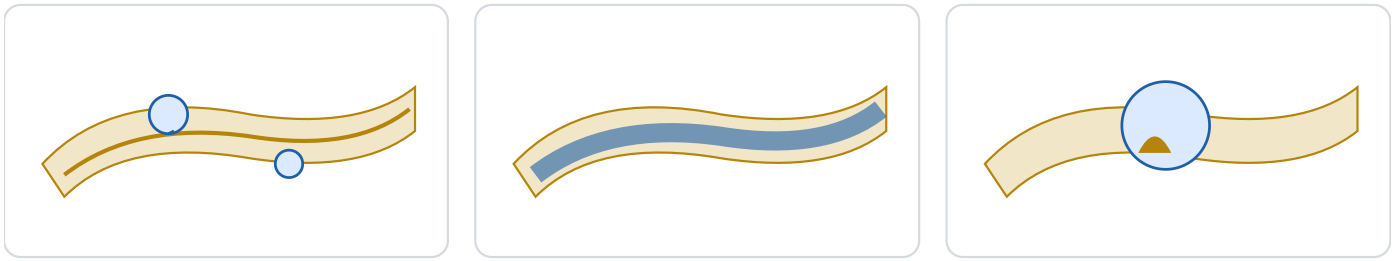
Risque
nodule (taille, rehaussement), paroi, stigmates et signes inquiétants

Évolution
croissance en mm/an par rapport aux examens antérieurs

Kystes du pancréas · TIPMP (Kyoto 2024) (suite)

ATLAS VISUEL

Types de TIPMP et signe de haut risque



Canaux secondaires
kystes communiquant avec le CPP

Canal principal
CPP > 5 mm · ≥ 10 mm = haut risque

Nodule mural
≥ 5 mm rehaussé = haut risque

Schémas simplifiés, non à l'échelle · CPP = canal pancréatique principal

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

TIPMP
Radiopaedia · types et signes
radiopaedia.org/articles/intraductal-papillary-m

Recommandations de Kyoto
Radiopaedia · synthèse
radiopaedia.org/articles/kyoto-guidelines-intrad

Cystadénome séreux
Radiopaedia · aspect microkystique
radiopaedia.org/articles/serous-cystadenoma-of-t

Néoplasme kystique mucineux
Radiopaedia · macrokystes
radiopaedia.org/articles/mucinous-cystic-neoplas

Sources : International evidence-based Kyoto guidelines 2024 – www.ahpba.org/wp-content/uploads/2025/02/Kyoto-IPMN-Guidelin...